MENEMUKAN KEMBALI DIRI MELALUI TERAPI

Jessica Florencia Avrilian

Depresi merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang paling sering ditemukan di seluruh dunia dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa lebih dari 280 juta orang mengalami depresi, menjadikannya salah satu penyebab utama disabilitas global. Depresi didefinisikan sebagai gangguan suasana hati yang ditandai oleh perasaan sedih mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya memberikan kesenangan, serta penurunan fungsi kognitif seperti daya konsentrasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengingat. Kondisi ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat (1). Selain itu, depresi sering kali menyebabkan gangguan pada sistem fisiologis tertentu, seperti pola tidur, regulasi hormon stres, serta metabolisme tubuh. Dampak yang kompleks tersebut menjadikan depresi sebagai kondisi multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dalam perawatannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, depresi tidak hanya menurunkan kualitas hidup penderitanya, tetapi juga memengaruhi hubungan interpersonal dan performa pekerjaan atau studi. Seseorang yang mengalami depresi kerap kali merasa kehilangan motivasi, mudah lelah, dan mengalami penurunan kepercayaan diri. Secara emosional, penderita cenderung merasakan kecemasan, rasa bersalah yang tidak rasional, hingga rasa tidak berharga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penderita depresi seringkali mengalami perubahan pada struktur dan fungsi otak, terutama di area yang berkaitan dengan regulasi emosi seperti amigdala dan korteks prefrontal (2). Perubahan-perubahan neurobiologis ini turut memperkuat penurunan kemampuan berpikir jernih serta mengelola tekanan emosional.

Salah satu dampak yang paling signifikan dari depresi adalah kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Keterasingan sosial ini

biasanya terjadi karena rasa takut menjadi beban bagi orang lain, rasa malu karena tidak mampu mengendalikan diri, atau hilangnya energi untuk melakukan interaksi sosial. Penelitian oleh Cacioppo dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa kesepian dan isolasi sosial tidak hanya memperburuk depresi, tetapi juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan fisik seperti penyakit kardiovaskular (3). Dengan demikian, depresi bukan hanya menjadi persoalan emosional dan psikologis, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan fisik seseorang.

Untuk mengatasi depresi, langkah pertama yang penting adalah menyadari adanya gejala yang muncul. Namun, tidak semua penderita mampu mengenali gejala depresi pada dirinya sendiri. Banyak individu mengabaikan perasaan sedih atau tidak berdaya yang berkepanjangan karena menganggapnya sebagai reaksi wajar terhadap kehidupan yang sulit. Bahkan, beberapa orang merasa malu atau takut mengakui bahwa dirinya mengalami masalah kesehatan mental akibat stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Stigma dapat mendorong seseorang untuk menekan emosinya dan menolak mencari bantuan, sehingga kondisinya semakin memburuk dari waktu ke waktu (13).

Dalam kondisi ini, *self-treatment* atau strategi penanganan mandiri dapat menjadi langkah awal yang membantu untuk mengurangi gejala depresi terutama pada tahap awal atau tingkat ringan. Salah satu bentuk *self-treatment* yang efektif adalah *art therapy*. *Art therapy* membantu individu mengekspresikan emosi secara kreatif, terutama emosi yang sulit dijelaskan melalui kata-kata. Kegiatan menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tertentu dapat membantu menurunkan hormon stres dan meningkatkan perasaan relaksasi. Penelitian oleh Kaimal dan rekan menunjukkan bahwa sesi seni sederhana selama beberapa menit dapat menurunkan kadar hormon kortisol yang berhubungan dengan stres (6).

Selain *art therapy*, *journaling* atau menuliskan perasaan dalam bentuk narasi pribadi juga menjadi metode yang sering direkomendasikan. Penelitian oleh Pennebaker menyatakan bahwa mengekspresikan perasaan melalui tulisan dapat membantu individu memahami emosinya dan memproses pengalaman traumatis

atau menekan dengan lebih efektif, sehingga memberikan efek positif terhadap kesehatan mental (7). Membuat toples kebahagiaan juga dapat menjadi teknik sederhana yang memberikan dampak emosional positif. Dengan menuliskan hal-hal menyenangkan yang terjadi dalam hidup, seseorang akan memiliki titik balik untuk mengingat hal-hal positif yang mungkin terabaikan saat depresi.

Self-treatment lainnya adalah mencari support system yang dapat dipercaya. Dukungan sosial diketahui berperan sebagai faktor protektif yang signifikan terhadap stres psikologis. Studi oleh Ozbay dan kolega menunjukkan bahwa kehadiran individu yang memberikan dukungan emosional dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan hidup dan memperkuat resiliensi psikologis (8). Oleh karena itu, dukungan keluarga, sahabat, atau komunitas sangat penting dalam memfasilitasi proses pemulihan.

Selain itu, menciptakan *safe place* baik secara fisik maupun mental dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi penderita depresi. *Safe place* dapat berupa tempat di rumah yang membuat seseorang merasa tenang atau rutinitas tertentu seperti meditasi, membaca buku, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Melakukan random aktivitas positif (RAP), seperti memberikan bantuan kecil kepada orang asing, juga dapat memberikan efek terapeutik karena individu merasa lebih terhubung dengan lingkungan sosialnya serta meningkatkan perasaan berarti dan berharga dalam hidup.

Namun, meskipun *self-treatment* dapat membantu, metode ini tidak selalu cukup untuk menangani depresi yang lebih berat. Jika gejala tidak membaik setelah beberapa waktu, sangat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan psikolog. Pada saat sesi pertama konseling, banyak penderita merasa ragu atau cemas karena harus membuka diri kepada orang yang tidak mereka kenal. Meski begitu, konseling memberikan ruang aman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan yang selama ini dipendam. Dalam konteks psikoterapi, terapi yang sering digunakan adalah *cognitive behavioral therapy* (CBT), yang fokus pada mengatasi

pola pikir negatif yang berkontribusi pada depresi (9). CBT telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi dan mencegah kekambuhan.

Proses konseling umumnya membutuhkan beberapa sesi selama beberapa minggu atau bulan, tergantung tingkat keparahan depresi. Psikolog akan memantau perkembangan dan menyesuaikan strategi terapi sesuai dengan kebutuhan pasien. Jika setelah menjalani konseling tidak ditemukan perbaikan yang signifikan, langkah berikutnya adalah konsultasi dengan psikiater. Psikiater dapat memberikan pengobatan yang dibutuhkan seperti antidepresan. Jenis antidepresan yang paling umum digunakan adalah *selective serotonin reuptake inhibitors* (SSRI) yang bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak. SSRI dikenal efektif dan memiliki efek samping yang relatif lebih rendah dibandingkan obat antidepresan generasi sebelumnya (10).

Pada kasus depresi berat atau depresi yang tidak merespons terhadap pengobatan standar, psikiater dapat merekomendasikan terapi alternatif seperti *electroconvulsive therapy* (ECT) atau *repetitive transcranial magnetic stimulation* (rTMS). Terapi-terapi ini telah menunjukkan hasil yang efektif bagi sebagian penderita, terutama mereka yang mengalami gangguan fungsi kognitif atau memiliki risiko tinggi terhadap percobaan bunuh diri. Penggunaan terapi berbasis alat seperti rTMS semakin sering digunakan karena sifatnya yang non-invasif dan minim efek samping.

Dalam perjalanan pengobatan, terdapat tantangan yang tidak sedikit. Salah satu tantangan utama adalah variabilitas respons individu terhadap terapi. Tidak semua penderita memberikan respons yang sama terhadap obat atau psikoterapi tertentu. Beberapa individu membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan perkembangan, sementara yang lain mungkin tidak merespons sama sekali terhadap metode tertentu. Selain itu, kekambuhan merupakan salah satu risiko terbesar dalam perjalanan depresi. Penelitian oleh Burcusa dan Iacono menunjukkan bahwa lebih dari separuh penderita depresi mengalami kekambuhan dalam beberapa tahun setelah pulih (11). Faktor-faktor yang memengaruhi kekambuhan antara lain stresor

lingkungan, kurangnya dukungan sosial, ketidakpatuhan terhadap terapi, serta predisposisi genetik.

Tantangan lain berasal dari akses terhadap layanan kesehatan mental yang masih belum merata. Di beberapa daerah, jumlah psikolog dan psikiater sangat terbatas sehingga pelayanan kesehatan mental sulit dijangkau oleh masyarakat. Biaya terapi yang relatif tinggi juga menjadi kendala bagi sebagian orang. Selain itu, stigma sosial terhadap depresi dan penyakit mental sering membuat penderita enggan mencari bantuan profesional. Banyak orang takut dianggap lemah atau tidak mampu menghadapi masalah hidup, sehingga memilih menyembunyikan kondisi mereka dan menanggung beban tersebut sendirian (13).

Meski demikian, terapi yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan penderita depresi. Penelitian oleh Cuijpers dan rekan menunjukkan bahwa terapi psikologis, terutama CBT, memberikan dampak yang besar dalam mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kualitas hidup (12). Dengan memahami pola pikir negatif yang menghambat, penderita dapat mulai membangun mekanisme koping yang lebih sehat dalam menghadapi stres. Terapi juga membantu individu untuk membangun kembali kepercayaan diri dan kemampuan interpersonal yang sempat hilang selama mengalami depresi.

Terapi bukan hanya bentuk pengobatan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Dengan mengikuti terapi, seorang penderita menunjukkan bahwa ia menghargai hidupnya dan bersedia untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi masa depan yang lebih baik. Setiap langkah kecil dalam terapi, mulai dari menyadari emosi, mengekspresikan perasaan, hingga menyusun tujuan hidup yang lebih bermakna, berkontribusi pada proses penyembuhan yang lebih besar. Pemulihan dari depresi tidak selalu linear; ada saatnya penderita merasa kembali terpuruk. Namun, keberanian untuk bertahan dan melanjutkan terapi merupakan faktor penting dalam proses pemulihan jangka panjang.

Pada akhirnya, memahami depresi sebagai kondisi medis yang dapat ditangani adalah langkah penting untuk mengurangi stigma. Depresi bukanlah kelemahan, melainkan pertanda bahwa seseorang membutuhkan bantuan. Baik terapi mandiri maupun terapi profesional memiliki peran masing-masing dalam proses pemulihan. Meskipun pemulihan memerlukan waktu yang panjang dan usaha yang konsisten, hasil yang diperoleh dapat membawa perubahan besar dalam cara seseorang memandang dirinya dan kehidupannya. Terapi merupakan titik awal perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih baik, dan setiap pengalaman selama proses tersebut memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan, ketabahan, dan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] World Health Organization. *Depression and other common mental disorders: global health estimates*. Geneva: WHO; 2017. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/depression-and-other-common-mental-disorders

[2] Rock PL, Roiser JP, Riedel WJ, Blackwell AD. Cognitive impairment in depression: a systematic review and meta-analysis. *Psychol Med*. 2014;44(10):2029–40. Available from: https://doi.org/10.1017/S0033291713002535

[3] Cacioppo JT, Grippo AJ, London S, Goossens L, Cacioppo S. Loneliness: clinical import and interventions. *Perspect Psychol Sci*. 2015;10(2):238–49. Available from: https://doi.org/10.1177/1745691615570616

[4] Malchiodi CA. *Art therapy and health care*. New York: Guilford Press; 2012. Available from: https://www.guilford.com/books/Art-Therapy-and-Healthcare/Malchiodi/9781609189752

[5] Smyth JM. Written emotional expression: effect sizes, outcome types, and moderating variables. *J Consult Clin Psychol*. 1998;66(1):174–84. Available from: https://doi.org/10.1037/0022-006X.66.1.174

[6] Kaimal G, Ray K, Muniz J. Reduction of cortisol levels and participants' responses following art making. *Art Ther*. 2016;33(2):74–80. Available from: https://doi.org/10.1080/07421656.2016.1166832

[7] Pennebaker JW, Chung CK. Expressive writing, emotional upheavals, and health. In: *The Oxford Handbook of Health Psychology*. Oxford: Oxford University Press; 2011. Available from: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195342819.013.0005

[8] Ozbay F, Johnson DC, Dimoulas E, et al. Social support and resilience to stress. *Psychiatry (Edgmont)*. 2007;4(5):35–40. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921311/

[9] Beck JS. *Cognitive behavior therapy: basics and beyond*. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2011. Available from:

https://www.guilford.com/books/Cognitive-Behavior-Therapy/Beck/9781609185044

[10] Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs. *Lancet*. 2018;391(10128):1357–66. Available from: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32802-7

[11] Burcusa SL, Iacono WG. Risk for recurrence in depression. *Clin Psychol Rev*. 2007;27(8):959–85. Available from: https://doi.org/10.1016/j.cpr.2007.02.005

[12] Cuijpers P, Berking M, Andersson G, et al. A meta-analysis of cognitive-behavioural therapy for adult depression. *Clin Psychol Rev*. 2013;33(1):8–23. Available from: https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.10.002

[13] Corrigan PW. How stigma interferes with mental health care. *Am Psychol*. 2004;59(7):614–25. Available from: https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.614